Nevrologiya

Logufen

Levetiratsetam

Tabletka 250 / 500 mg

Tutqanoqqa qarshi (N03AX14), SV2A oqsiliga bog'lanadi



QISQACHA · **Monoterapiya: 250 mg ×2 dan, 2 haftadan keyin 500 mg ×2. Qo'shimcha terapiya: 1-kundan 500 mg ×2. Doza buyrak funksiyasiga qarab.**

Ko'rsatmalar

- Monoterapiya: 16 yoshdan, yangi tashxislangan parsial tutqanoqlar
- Qo'shimcha: 6 yoshdan parsial tutqanoqlar
- Qo'shimcha: 12 yoshdan yuvenil mioklonik epilepsiyada mioklonik va idiopatik generalizatsiyalangan epilepsiyada tonik-klonik tutqanoqlar

Dozalash

- Monoterapiya: 250 mg ×2 → 2 haftadan keyin 500 mg ×2; har 2 haftada +250 mg ×2; maks. 1500 mg ×2
- Qo'shimcha (≥50 kg): 1-kundan 500 mg ×2; maks. 1500 mg ×2
- Buyrak (KK): 50–79 → 500–1000 mg ×2; 30–49 → 250–750 mg ×2; <30 → 250–500 mg ×2
- To'xtatish asta: har 2–4 haftada 500 mg ×2 ga kamaytirish

Mumkin emas

Levetiratsetam yoki pirrolidon hosilalariga o'ta sezuvchanlik

Nojo'ya ta'sirlar

Nazofaringit, uyquchanlik, bosh og'riq, bosh aylanishi, holsizlik; asabiylik, tajovuzkorlik, depressiya — kuzatish

Vrach so'rasa — asosiy dalillar

- Jigarda metabolizmlanmaydi, CYP450 bilan ishlamaydi — boshqa dorilar bilan deyarli o'zaro ta'sir yo'q
- Birinchi kundan samarali dozadan boshlash mumkin; chiziqli farmakokinetika
- Kuniga 2 marta; biokiraolishlik ~100%, ovqatga bog'liq emas

KOMPANIYA MATERIALI (PM) · yo'riqnomadan emas

«Logufen — to'lqin kuchini nazoratga ol!»

- SV2A ga ta'sir — noyob mexanizm; barcha asosiy epilepsiya shakllarida
- Cmax ~1,3 soatda, biokiraolishlik ~100%, ovqatga bog'liq emas
- Samarali dozadan boshlash mumkin; kuniga 2 marta

⚠ SPV da "titrlash shart emas" deyilgan; yo'riqnomada monoterapiya 250 mg ×2 dan boshlanadi — imtihonda yo'riqnoma bo'yicha javob bering.

O'zingizni tekshiring

Logufenning asosiy farmakokinetik afzalligi?
Jigarda metabolizmlanmaydi, CYP450 orqali ishlamaydi — o'zaro ta'sir deyarli yo'q; buyrak orqali chiqadi.

Logufen monoterapiyasi qanday boshlanadi?
250 mg kuniga 2 marta, 2 haftadan keyin 500 mg kuniga 2 marta.